

EXAMEN CLINIQUE DE L'ÉPAULE

GÉNÉRALITÉ

Trois articulations:

- Gléno-humérale (humérus-omoplate)
- Scapulo-thoracique (ce n'est pas une articulation)
- Acromio-claviculaire (acromion-clavicule) : risque de friction et de douleurs

Mobilité

- Abduction :
 - Mouvements gléno-huméraux: 0-90°
 - Glissement scapulo-thoraciques : 90-160°
- Antépulsion/Rétropulsion : 165°-0-60°
- Rotations interne/externe: 0-70°

La ceinture scapulaire en relation directe avec le rachis cervical. Les muscles de la ceinture sont tous innervés par les racines C5-C6. Une lésion de C5-C6 provoque des douleurs projetées sur la ceinture scapulaire. Il faut toujours demander au patient s'il ne ressent pas de douleur lorsqu'il bouge (tourner ou latéraliser) sa tête de manière à écarter une étiologie rachidienne.

EXAMEN PHYSIQUE

L'examen doit toujours être bilatéral, comparatif et symétrique

INSPECTION

Déshabiller le patient (l'examineur regarde le patient se déshabiller)

Observer des :

- Tuméfactions
- Déformations
- Amyotrophies: le plus important
- Attitudes antalgiques

PALPATION

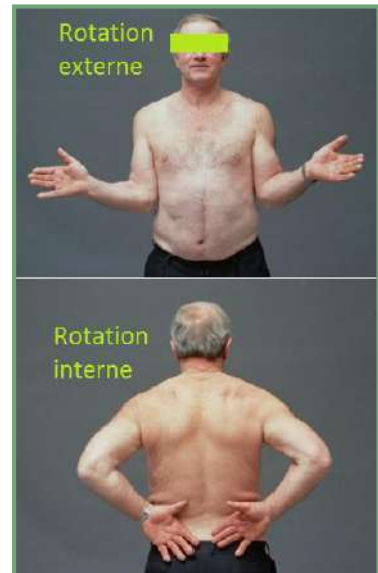
La palpation est difficile car l'articulation se situe 2-3 poches musculaire.

- Recherche de zones douloureuses
- Acromio-claviculaire
- Relief de la coracoïde
- Sterno-claviculaire
- Gouttière bicipitale: **comment palper?**
- Insertions sus- et sous-épineux
- Sensibilité faible

MOBILISATION

Etude des amplitudes

- Actives : tester la coiffe des rotateurs:
 - Flexion et antépulsion des bras
 - Abduction et adduction
 - Rotation interne/rotation externe
 - *Si le patient ne fait pas le mouvement totalement. L'examineur exécute le mouvement de manière passive.*
 - *Si amplitudes actives diminuées mais amplitudes passives normales, il s'agit d'un problème musculaire, neurologique (coiffe, lésion neurologiques).*
 - *Si limitation des amplitudes en actif et en passif, il s'agit d'une raideur articulaire, capsulite rétractile.*



- Passives : capsule -> On recherche une rétraction de la capsule
La capsule est constitué de 4 muscles (reliant l'omoplate à l'humérus):

- Sus-épineux (supraspinatus):
 - O.: fosse sus-épineuse; T.: Partie haute du trochanter; N.: nerf suprascapulaire (C5-C6); M.: abducteur (avec le m. deltoïde)
 - Test de Jobe:

L'examineur lève les bras du patient à 90°, paume des mains en arrière.

Il place les bras en antépulsion à 30° de manière à ce qu'ils soient dans l'axe des omoplates.

Il appuie de manière symétrique tandis que le patient résiste.
L'examineur évalue la diminution de force.



- Sous-épineux (infraspinatus):
 - O.: fosse infra-épineuse; T.: face postérieure du trochanter; N.: suprascapulaire (C5-C6); M.: rotation externe (avec le m. petit rond)



- Rotation externe contre résistance:

Le patient place membres supérieurs en rotation externe moyenne, coudes collés contre le corps, poings fermés.

L'examineur applique une force symétrique vers l'intérieur à laquelle le patient se doit de résister.

L'examineur évalue la diminution de force. Le test est positif s'il y a diminution de force.

- Signe du portillon (ou rappel automatique)



Le patient fléchit son bras.

L'examineur déplace passivement le bras vers l'extérieur et lâche le bras.

Le signe du portillon correspond à une rotation interne du bras. Lorsque l'examineur à lâcher le bras, le patient ne peut s'empêcher de ramener son bras vers son abdomen.



- Petit Rond (Teres Minor):

- O.: $\frac{3}{4}$ inférieurs bord lat. omoplate; T.: face postéro-inférieure trochanter; N.: nerf axillaire; M.: rotateur externe lorsque le bras est en abduction
- Manœuvre de Patte:

L'examineur soulève le bras du patient et le place à 90° en abduction et en rotation externe (comme lors d'un serrement).

L'examineur pousse ensuite le bras vers l'avant.

Le patient résiste.

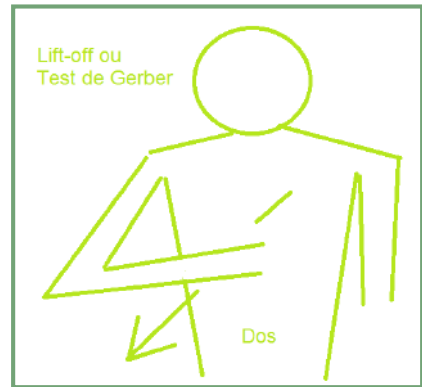
L'examineur évalue la force.

- Signe du clairon:



En l'absence de rotateurs externes, le patient n'arrive pas à amener sa main à la bouche normalement. Pour compenser, il doit lever le coude plus haut que le main.

- Sous-Scapulaire (subscapularis)
 - O.: face antérieure omoplate; T: trochanter;
 - N.: Nerfs subscapulaires supérieurs et inférieurs (C5-C6); M.: Rotateur interne
 - Lift-off ou test de Gerber:



Le patient place sa main dans le dos et doit la décoller en s'éloignant du dos.

Le test est positif s'il y a une diminution de force ou lorsque le patient est incapable de réaliser le test.



- Internal Rotation Lag ou signe de Hertel (signe du portillon bis):

L'examineur place passivement le bras fléchi du patient (paume contre le dos) derrière le dos.

Il lâche le bras.

Si le patient ramène le bras près du dos, le test est positif.

- Belly Press:

Le patient place sa main sur son ventre.

Le coude doit toujours être en avant.

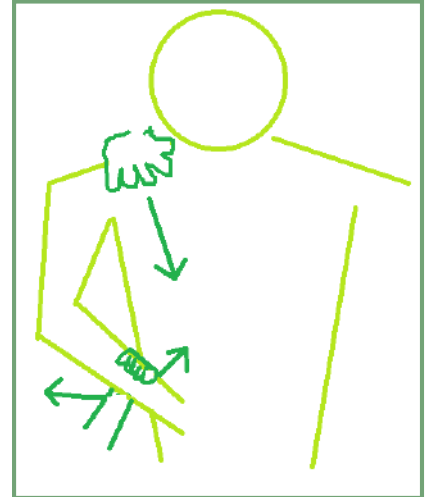
Le patient appuie uniquement avec sa main sur son ventre. L'examineur tire le bras en avant.

Le patient doit résister à la traction.

L'examineur évalue la force de résistance.



- Long chef du biceps
 - O.: pôle sup de la glène et bourrelet supraglénodien; T.: dans la gouttière bicipitale
 - Le tendon intra-articulaire peut se rompre. La palpation réveille parfois les douleurs.
 - L'examineur bloque l'épaule en compressant avec sa main. Il saisit ensuite l'avant-bras du patient et effectue des rotations.
 - Après quelques rotations, en cas de ruptures ou tendinite, le patient énonce une douleur.
 - Palm-up test:



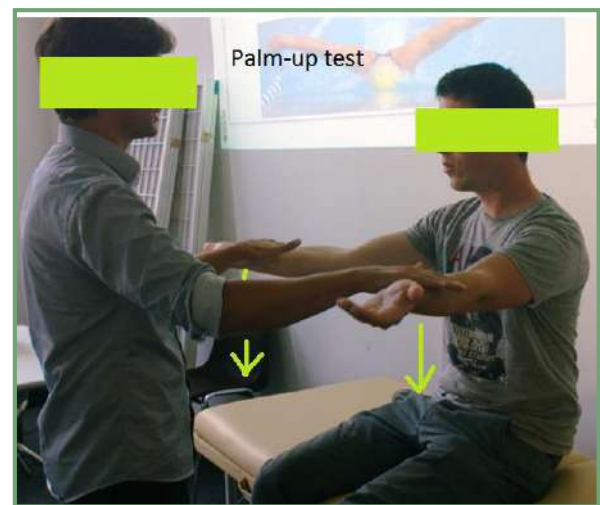
Le patient étend ses bras en avant, les paumes vers le ciel.

L'examineur appuie sur la avant-bras vers le bas.

Le patient résiste.

L'examineur évalue cette résistance.

Ce test révèle les douleurs le trajet du long biceps.



CONFLIT SOUS-ACROMIAL

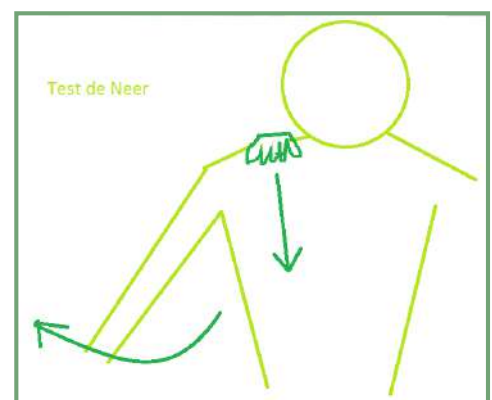
L'humérus tourne de manière quasi libre sous l'acromion. Le ligament thoraco-acromiale recouvre l'articulation. Son insertion, l'anthèse du ligament, avec l'âge et l'activité professionnelle (bâtiment), a tendance à se calcifier. En se calcifiant, l'espace sous l'acromion est réduit et le muscle sous-épineux se retrouve coincé entre deux os (acromion et humérus). Cette lésion dégénérative de coiffe provoque le déchirement du muscle sous-épineux.

Avant de se déchirer, le muscle sous-épineux provoque une douleur, le conflit sous-acromial.

Ce conflit est difficile à prouver. Il constitue un faisceau d'arguments. Il y a différents test qui sont peu spécifiques.

Le patient se plaint de douleurs entre 60° et 120° d'abduction (durant lesquels la pression est la plus forte)

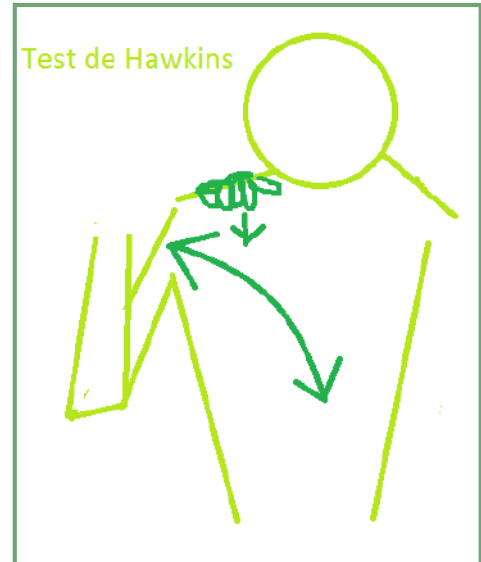
- Test de Neer:
 - L'examineur bloque l'omoplate en plaçant sa main sur l'épine et l'acromion.



- Le patient place son bras en pronation.
- L'examineur fléchit passivement le bras.
- Vers le 120°, le patient, si le test est positif, ressent une douleur.
- Si le bras est alors mis en supination, la douleur du patient est soulagée.

- Signe de Hawkins

- Le patient place le bras en avant. Il fléchit le bras.
- L'examineur bloque l'omoplate en plaçant sa main sur l'épine et l'acromion.
- Il place sa main sur l'avant-bras de l'examineur et effectue des rotations internes.
- Si le test est positif, le patient ressent une douleur entre 60° à 90°.



LAXITÉ-INSTABILITÉ DE L'ÉPAULE

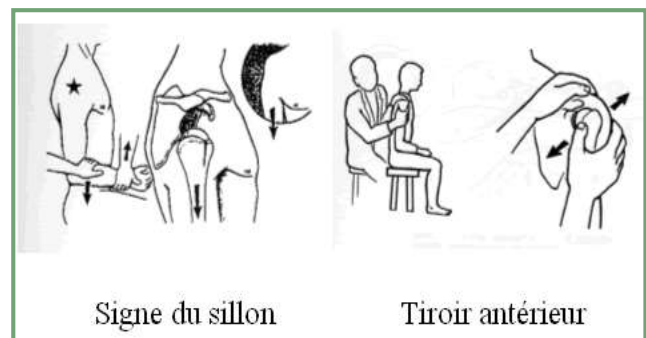
La laxité (souplesse). est une entité objective, quantifiable à l'examen clinique par l'examineur.

L'instabilité est une entité purement subjective ressentie par le patient : "Mon épaule ne tient pas. Je ne peux pas lancer un objet".

Une personne instable n'est pas hypolaxe. La laxité peut être démontrée passivement. Une épaule hyperlaxe n'est pas forcément instable, et une épaule instable n'est pas forcément hyperlaxe...

- Hyperlaxité inférieure:

- L'examineur tire le bras vers le bas.
- Si le patient est hyperlaxe, l'examineur peut ressentir la luxation ou bien aperçoit le signe du sillon, c'est-à-dire un creux sous l'acromion.
- Cette hyperlaxité s'accompagne du tiroir antéro-postérieur.
- L'examineur bloque l'omoplate en plaçant sa main sur l'épine et l'acromion.

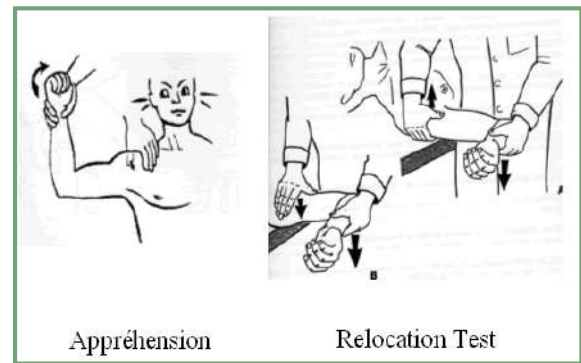


- Avec son autre main, l'examineur saisit l'humérus et applique une force antérieure et une autre postérieure.

- Instabilité antérieure:

- Test d'appréhension et test de recentrage antéro-postérieur:

- L'examineur essaie de provoquer un mouvement de luxation, à savoir un mouvement de lancé.
 - Il place, passivement, le bras du patient en abduction à 90°.



- L'examineur effectue une rotation externe au même moment où il appuie avec son pouce, en avant, sur la tête humérale.
 - Le patient instable ressent normalement une douleur.
 - (Ce test peut aussi être effectué couché)

- Instabilité postérieure:

- L'examineur place le bras du patient vers l'avant.
 - Le patient effectue une rotation interne de manière à dégager la tubérosité.
 - L'examineur appuie sur l'omoplate par derrière.
 - Il pousse de manière forte sur le coude en arrière de manière à subluxer la tête humérale.
 - La patient ressent une douleur. La tête humérale est plus stable qu'antérieurement.

